

02 - 02- Abscès Pulmonaire - Pr. Bouchentouf

(0:02 - 0:47)

Bonjour chers étudiants, le cours d'aujourd'hui c'est l'abcès pulmonaire. Le plan du cours comporte une introduction, études pathogéniques, études cliniques, diagnostics différentiels et le traitement de l'abcès pulmonaire. L'abcès pulmonaire, c'est une supuration collectée dans une cavité néoformée, creusée dans le parenchyme par une infection aiguë non-tuberculeuse.

(0:48 - 1:18)

Sans exclure de la définition de l'abcès pulmonaire, les supurations sur des cavités existantes c'est-à-dire l'abcédation de bulles, de cavités du tuberculeuse ou de kystes aériens, de kystes didactiques, de cancers excavés ou de dilatations de branches kystiques. On sous-estime sa fréquence. L'abcès pulmonaire, il est rare.

(1:19 - 1:50)

Sa fréquence est diminuée depuis l'ère des antibiotiques. Les germes responsables sont de plus en plus souvent des germes résistants. Trois notions essentielles à retenir.

L'abcès survient sur un terrain fragile. Le traitement médical précoce est efficace. La fibroscopie bronchique est indispensable en cas d'abcès pulmonaire.

(1:54 - 2:08)

On se concentre à l'étiopathogénie. Les agents pathogènes, c'est souvent un abcès d'origine bactérienne. Il peut être des germes aërobies ou anaërobies.

(2:08 - 2:32)

Les aërobies ont des grammes négatifs, comme l'éclésiase, l'apnémonia, le pseudomonas aërogenosa, le bacillus proteus, les grammes positifs, le staphylococque doré. Également des germes anaërobies. On oublie qu'il y a des abcès pulmonaires, peut-être d'origine amibienne, d'origine parasitaire.

(2:32 - 2:45)

On a parlé que l'abcès survient sur un terrain fragile. Ce sont les facteurs favorisants. Le terrain est toujours particulier.

(2:46 - 3:08)

L'abus d'alcool, le tabagisme, le diabète, une corticothérapie au long cours, un traitement immunosuppresseur, une réanimation respiratoire. Également, on cherche une porte d'entrée qui

doit être soigneusement recherchée. Cette porte d'entrée peut être dentaire, sudnusienne ou cutanienne.

(3:08 - 3:28)

Dans le cas dentaire, on cherche les germes anaërobies. L'inoculation du parenchyme, qui doit être responsable de l'abcès pulmonaire, se fait soit par voie bronchique, soit par voie vacculaire. La voie bronchique, c'est la situation la plus fréquente.

(3:28 - 3:45)

L'inhalation de particules septiques ou de regurgitations, et la fréquence de l'atteinte des cernes dorsales, de l'inhalation. Donc, c'est pour soi qu'il y a une atteinte des segments dorsaux. Par voie vasculaire, c'est une volonté rare.

(3:45 - 4:09)

Il s'observe surtout au milieu hospitalier et provoque la formation d'abcès multiples. L'étude clinique, on apprend comme type de description la forme typique de l'abcès pulmonaire. On a trois phases.

(4:09 - 4:23)

Phase de foyer fermé, c'est un tableau de pneumopathie aiguë-fibrile. Il y a une phase de rupture de vomique. La vomique, vous allez la voir dans le cas d'abcès ou au cas de kystidatique.

(4:23 - 4:39)

Cette vomique peut être massive, fractionnée ou numulaire. Il y a une phase de foyer ouvert où l'état général s'altère. On aura une fièvre qui est oscillante.

(4:39 - 5:04)

On aura également une expectoration plus longue parfois du sang. L'image radiologique, les signes radiologiques et les quatre grands signes radiologiques sont l'image hydroaérique. Avec une paroi, c'est l'image hydroaérique.

(5:05 - 5:22)

Avec la paroi qui est fine, on recherchera une branche de drainage. Et il y aura une variabilité du niveau lorsqu'on refait les examens. Au cas d'abcès, il faut faire un bilan.

(5:22 - 5:34)

Il va comporter un bilan au niveau de la porte d'entrée. L'examen de la porte d'entrée, de la recherche de la porte d'entrée cutanée, oréelle ou surtout dentaire. L'aspect du dent, l'état

dentaire.

(5:35 - 5:52)

Rechercher les facteurs favorisant le diabète, le coma éthylique, la pollution, le tabagisme. Si il y a une option d'intervention chirurgicale raison. Et rechercher les causes leucorégionales, un obstacle intrabronchique, donc l'intérêt de la fibroscopie.

(5:53 - 6:11)

Rechercher une compression extrinsèque, une pneumonie, une dilatation des causes oréelles ou des causes digestives. L'examen biologique, un bilan inflammatoire, la VSL, la pélapérocitonine. Une numération de formules sanguines à la recherche d'une hyperleucocytose.

(6:12 - 6:29)

Et rechercher une terre métabolique, particulièrement indiabète. Sans oublier les examens microbiologiques, par des hémocultures, par l'examen cytobac des expectorations. Par des prélèvements qu'on fait au cours de la broncoscopie.

(6:30 - 6:38)

Rechercher une porte d'entrée éventuelle. Prélèvement du pus pleural. Sans oublier qu'il faut toujours éliminer une tuberculose.

(6:38 - 6:57)

Donc rechercher les BK à l'examen direct et à la culture. Très important. Toute abcédation pulmonaire ou pleural justifie une fibroscopie bronchique à la recherche d'une mycoplasme bronchique.

(6:57 - 7:16)

Il faut retenir cet élément très très important. L'évolution, comment surveiller l'évolution ? Les éléments de surveillance sont toujours cliniques, biologiques et radiologiques. Clinique, on va chercher la courbe des expectorations, la température et l'état général.

(7:16 - 7:32)

Biologique, l'annumération de formules sanguines, le syndrome insulatoire, c'est-à-dire VSSAP. Également radiologiques, radiographiques, thoraciques. Les critères de guérison, c'est une agression totale des signes fonctionnels et généraux entre 10 à 15 jours.

(7:33 - 7:46)

Normalisation de l'anumération de la VS. Et le nettoyage radiologique entre 3 à 6 semaines. Les séquelles peuvent être stables en recherche des cavités résiduelles à parois fines et images stellaires.

(7:46 - 8:09)

Vous voyez que le nettoyage radiologique est stable par rapport à l'amélioration des signes cliniques et fonctionnels. Les complications de l'abcès, ce sont peut-être des complications loco-régionales ou générales. Le loco-régional des cavités peut s'infecter, une tuberculose, une greffe aspergillaire.

(8:09 - 8:19)

L'abcès peut se réduire, peut se compliquer de dilatation de bronches. L'abcès peut se remplir de la plèvre dans l'haplomotoraxe. Il peut se compliquer de pleurises périllantes au pieuplemotoraxe.

(8:19 - 8:34)

Il peut se compliquer d'endocardite, de péricardite. Également, les complications dégénérales comme l'abcès du cerveau, les septicémies et la mylose rénale. La mylose, c'est une complication des infections chroniques.

(8:35 - 8:50)

Les formes cliniques, on distingue les formes symptomatiques et des formes selon le germe. Les formes symptomatiques, ce sont des formes révélées par une complication. Les abcès peuvent être multiples.

(8:51 - 9:09)

Le germe responsable, c'est la staphylocoque. Et les formes subériques, un aspect pseudo-tuberculeux. Selon le germe, on distingue les germes en écrasant les plus fréquents sur le staphé, les bacilles gravidatives et les anaérobies sont liées à l'abcès amibien.

(9:11 - 9:31)

L'abcès amibien, c'est un abcès d'origine paraditaire, caractérisé par une vomite brun-chocolat. Il est siège surtout au niveau basal droit, au niveau de la base du poumon droit. Son caractère est amicrobien, abactérien.

(9:32 - 9:52)

Il faut rechercher, si on suspecte un abcès amibien, les antécédents d'amibiase intestinale et un aspect amibien hépatique. Le diagnostic est sérologique et le traitement des preuves, c'est l'hémithine. Le diagnostic différentiel.

(9:54 - 10:29)

Devant une supération sur la cavité, ce sont les principaux diagnostics différentiels de l'abcès pulmonaire. On peut citer cavernes tuberculeuses, un kystidatique pulmonaire surinfecté, un infarctus pulmonaire surinfecté, un cancer bronchopulmonaire excavé, un aspergillum surinfecté et du bouldard d'enfysème surinfecté. Le diagnostic différentiel, c'est les pyopneumothorax conquistés et les supérations sous-diaphragmatiques.

(10:33 - 10:48)

Parmi les diagnostics différentiels, c'est le kystidatique fussed. Vous voyez ca, c'est le kystidatique fussed. C'est le croissant gazeux.

(10:51 - 11:09)

Le deuxième diagnostic différentiel, on aura les bulles surinfectées. Les bulles d'enfysème surinfectées. Également, le diagnostic différentiel, c'est l'aspergillose.

(11:09 - 11:29)

Vous regardez cette image en grelou. Parmi les diagnostics également différentiels de l'abcès, c'est le pyopneumothorax. Vous avez sur la radio, vous avez des images mixtes.

(11:29 - 11:47)

Un pneumothorax à gauche avec un niveau aérique. C'est un hydropneumothorax parce que c'est purulent par du pyopneumothorax. Parmi les diagnostics différentiels également, c'est le cancer pulmonaire.

(11:55 - 12:14)

Le traitement de l'abcès pulmonaire. Tout d'abord, essentiellement, c'est un traitement médical. Basé sur une antibiotérapie qui comporte une association d'antibiotiques qui doit être synergique et par voie parentérale.

(12:14 - 12:33)

C'est-à-dire que l'antibiotérapie doit être précoce, adaptée, reposant sur des prélèvements fiables avec une durée prolongée. Je peux aller jusqu'à 8 semaines, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 mois. La kinésithérapie respiratoire est essentiellement très importante.

(12:33 - 13:11)

Sans oublier le traitement d'une maladie générale, l'extraction d'un corps étranger et le traitement d'une porte d'entrée et d'un foyer sceptique. En ce qui concerne le traitement chirurgical, il est

indiqué en cas d'abcès chronique, en cas d'abcès récidivant avec des hémoptysis, en cas d'abcès compliqué de dilatation de branches localisées, en cas de tumeur branchique abcédée. Bien sûr, si la tumeur est opérable.